

Cauchemars et rêves intenses induits par les médicaments

😱 Les cauchemars sont des expériences banales en particulier chez l'enfant. Ils peuvent parfois être le symptôme d'un trouble psychiatrique, comme le trouble de stress post-traumatique (TSPT) où les cauchemars sont un des symptômes de la reviviscence traumatique.

💊 Un point moins connu est que certains médicaments peuvent induire l'apparition de cauchemars ou des rêves très intenses. La plupart de ces médicaments ont un impact sur les neurotransmetteurs impliqués dans la régulation du sommeil paradoxal, pendant lequel ont lieu les rêves dont nous nous souvenons.

😱 Le plus souvent, cet effet indésirable survient rapidement après le début du traitement. De nombreux médicaments non psychotropes peuvent induire des cauchemars.

🎯 Les β -bloquants sont le plus souvent en cause, car leurs nombreuses indications concernent des pathologies fréquentes (hypertension artérielle, insuffisance coronarienne, migraine, etc.)
▶ cet effet s'observe surtout avec les β -bloquants dits "lipophiles" passant la barrière hémato-méningée, c'est-à-dire qui peuvent atteindre le cerveau. Les autres sont "bloqués" et ont donc peu d'effet sur les rêves.
▶ par exemple le propranolol très prescrit en psychiatrie est lipophile, l'aténolol non lipophile est une bonne alternative.

🎯 Les autres médicaments non psychotropes sont (liste non exhaustive)
▶ agonistes dopaminergiques (maladie de Parkinson)
▶ agonistes α -adrénergiques (NB : en miroir les α -bloquants sont un traitement des cauchemars du TSPT)
▶ inhibiteurs de l'enzyme de conversion
▶ agonistes cholinergiques
▶ de nombreux médicaments anesthésiques (kétamine, etc.)

⚠ un point de vigilance avec l'antipaludéen méfloquine : l'apparition de cauchemars est un signe d'alerte pour la survenue d'un épisode psychotique pharmaco-induit, pouvant justifier l'arrêt préventif du traitement.

🎯 Les médicaments psychotropes les plus souvent impliqués sont :
▶ antidépresseurs : surtout la mirtazapine, moins souvent les ISRS (inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine) et les autres antidépresseurs
▶ médicaments du sevrage tabagique : surtout les substituts nicotiniques, pouvant nécessiter le retrait des patches de nicotine pendant la nuit
▶ antihistaminiques : prévenir les personnes traitées par hydroxyzine qu'elles pourront faire des rêves bizarres !

😱 L'apparition de cauchemars ou de rêves très intenses peut aussi arriver à l'arrêt d'un traitement supprimant le sommeil paradoxal, du fait d'un effet "rebond"
▶ benzodiazépines et hypnotiques apparentés (zopiclone)
▶ antidépresseurs ISRS et tricycliques



En pratique, deux points importants :

- ▶ penser à éliminer une étiologie iatrogène chez une personne rapportant l'apparition de cauchemars avant de les imputer à un trouble psychiatrique
- ▶ éviter de prescrire des médicaments inducteurs de cauchemars à des personnes qui présentent un TSPT, donc bien choisir les β -bloquants utilisés !

Références ↓

<https://doi.org/10.1177/02698811211034810>

<https://doi.org/10.1002/hup.465>

Cauchemars et rêves intenses induits par les médicaments	
médicaments non psychotropes	médicaments psychotropes
β-bloquants "lipophiles" ⚠ passent la barrière hémato-méningée ↳ relai par un non-lipophile par ex aténolol ⚠ si trouble de stress post-traumatique méfloquine (antipaludéen) ⚠ ↳ prodrome d'un épisode psychotique ? autres médicaments ↳ agonistes dopaminergiques ↳ agonistes α-adrénergiques ↳ inhibiteurs de l'enzyme de conversion ↳ agonistes cholinergiques, etc.	à l'introduction du médicament ↳ antidépresseurs ✧ surtout mirtazapine ✧ ISRS* ↳ substituts nicotiniques ↳ antihistaminiques * inhibiteur sélectif du recaptage de la sérotonine à l'arrêt du médicament rebond de sommeil paradoxal ↳ benzodiazépines et apparentés ↳ antidépresseurs tricycliques et IRSR

